CIRUGÍA BARIÁTRICA Y METABÓLICA

DRA. DEBBIE WONG

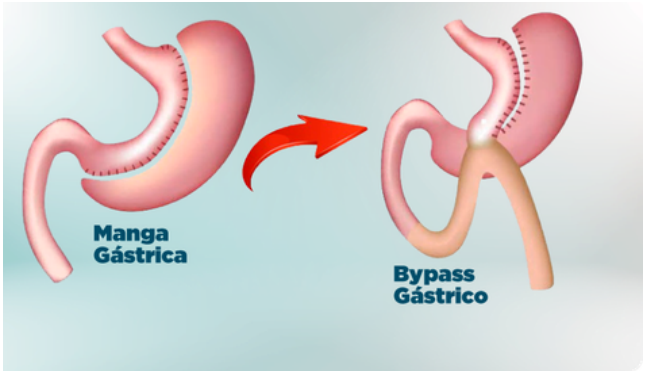
INDICACIONES SEGÚN IMC (ASMBS/IFSO 2022)

- IMC ≥40: candidatos directos, independiente de comorbilidades.
- IMC ≥35 con comorbilidades (DM2, HTA, SAOS, dislipidemia): indicación quirúrgica.
- Indicación metabólica especial: IMC 30-34.9 con DM2 mal controlada pese a tratamiento médico optimizado.
- Éxito quirúrgico: pérdida y mantenimiento de ≥50% del exceso de peso a los 5 años.

LA CIRUGÍA IDEAL ES:	Indicaciones para LA CIRUGÍA BARIÁTRICA:
⇨ Segura, con poco índice de complicaciones ⇨ De mínima invasión y con pocos efectos secundarios. ⇨ Efectiva ⇨ Con resultados a largo plazo ⇨ Ofrece una buena calidad de vida al paciente ⇨ Ajustable ⇨ Reversible	⇨ IMC mayor de 40 ⇨ IMC mayor de 35 con presencia de comorbilidad ⇨ Obesidad mórbida mantenida por más de 3 años ⇨ Edad comprendida entre los 15 y 18 años con IMC mayor a 40 en presencia de comorbilidades o mayor a 50 sin comórbidos ⇨ Edad comprendida entre los 60 y 70, con riesgo operatorio aceptable

TÉCNICAS RESTRICTIVAS Y MIXTAS

- Gastrectomía vertical (sleeve): la más practicada; reseca ~80% del estómago, reduce la ghrelina.
- Bypass gástrico en Y de Roux: gold standard; reservorio pequeño + malabsorción moderada + estímulo incretinico.
- Cruce duodenal: alto componente malabsortivo, para superobesidad (IMC>50).

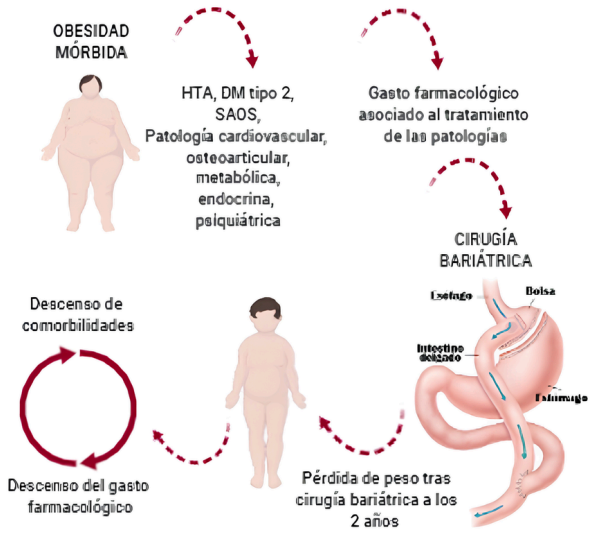


COMPLICACIONES Y SEÑALES DE ALERTA

- Respiratorias: causa más frecuente de morbilidad médica posoperatoria (atelectasias, neumonía, TEP).
- Fugas/dehiscencias: emergencia más crítica; la taquicardia sostenida >120lpm es el signo más precoz, precediendo a fiebre o irritación peritoneal.
- Hernia interna (espacio de Petersen): propia del bypass en Y de Roux; dolor periumbilical cólico con alto riesgo de necrosis isquémica.

FISIOLOGÍA METABÓLICA DEL CAMBIO DE PARADIGMA

- La cirugía bariátrica evolucionó a cirugía metabólica: sus efectos van más allá de la restricción/malabsorción, modulando hormonas enteroinsulares (↑GLP-1, ↑PYY, ↓ghrelina) para el control integral de la obesidad y sus comorbilidades.



CIRUGÍA BARIÁTRICA Y METABÓLICA

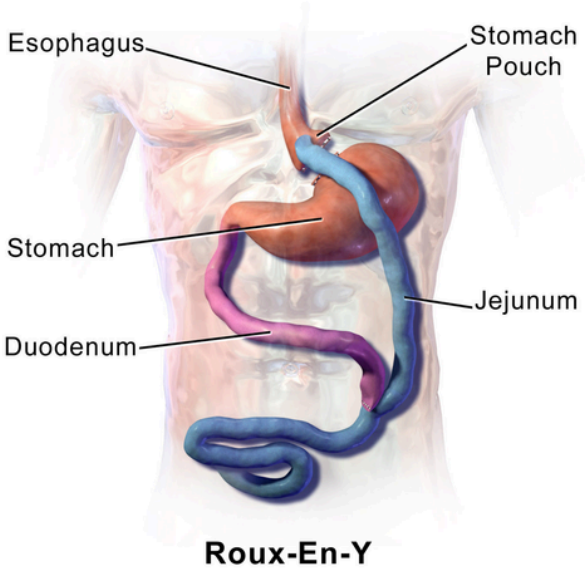
DRA. DEBBIE WONG

GASTRECTOMÍA EN MANGA

- Se remueve ~80% del estómago dejando una manga estrecha: menor capacidad y menos grelina.
- Ventajas: pérdida de peso significativa y menos deficiencias que el bypass. Desventajas: irreversible y posible reflujo.

BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX

- Pequeña bolsa gástrica conectada al intestino delgado: limita la ingesta y la absorción.
- Ventajas: pérdida sostenida y mejora rápida de la diabetes tipo 2. Desventajas: más complejo, más deficiencias y dumping.



Roux-En-Y

BANDA GÁSTRICA AJUSTABLE

- Banda alrededor de la parte superior del estómago que crea una pequeña bolsa.
- Ventajas: menos invasiva, reversible y ajustable. Desventajas: menor pérdida de peso, deslizamiento o erosión.

DERIVACIÓN BILIOPANCREÁTICA CON CRUCE DUODENAL

- Manga + mayor desviación intestinal: reduce la ingesta y la absorción.
- Ventajas: mayor pérdida de peso y excelente control de la diabetes. Desventajas: más compleja, más deficiencias y complicaciones.

BENEFICIOS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

- Pérdida del 50–70% del exceso de peso en los dos primeros años; mejora o resolución de diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño e hígado graso; mejor movilidad, menos dolor articular y mejor autoestima.

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

- Infección, sangrado y fuga anastomótica.

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

- Hierro, calcio, vitamina B12 y vitamina D.

PROBLEMAS DIGESTIVOS

- Náuseas, vómitos, reflujo y síndrome de dumping (especialmente tras el bypass).

COMPLICACIONES A LARGO PLAZO

- Hernias, obstrucción intestinal y úlceras.

CONSIDERACIONES POSTOPERATORIAS

- Seguimiento con cirujano, nutricionista y psicólogo; suplementación de vitaminas y minerales; dieta balanceada y ejercicio; grupos de apoyo y terapia.